

Цистограмма — короткое рентгенологическое исследование мочевого пузыря. Пузырь осторожно заполняют контрастным веществом через катетер, чтобы он был чётко виден на снимке. Это позволяет хирургу проверить, зажила ли операционная зона и нет ли утечки, свища или заброса мочи к почкам.

Об этом исследовании

На обычном рентгеновском снимке мочевой пузырь практически не виден. Цистограмма заполняет его **контрастным веществом**, которое выглядит белым, поэтому хорошо видны форма пузыря и его работа. Врач назначает цистограмму, чтобы:

- Убедиться, что **хирургическая зона зажила** без утечки — обычно перед удалением катетера
- Выявить **утечку** после травмы или операции
- Обнаружить патологическое сообщение (**свищ**) между пузырём и соседним органом
- Проверить заброс мочи из пузыря к почкам (**рефлюкс**)

Способ введения контраста зависит от ситуации:

- Если у вас **нет катетера**, его устанавливают только на время исследования.
- Если уже стоит **уретральный катетер** или **надлобковый катетер**, контраст вводят через него — новая трубка не нужна.

Это безопасно?

Да. Цистограмма — распространённое исследование с низким риском. Доза облучения минимальна, а водорастворимый контраст выводится с мочой. Большинство пациентов ощущают лишь чувство наполненности или лёгкое давление. Редкие нежелательные эффекты — инфекция мочевыводящих путей (UTI), кратковременное жжение или спазм — как правило, слабые и быстро проходят.

ТЕРМИНЫ

Цистограмма

Рентгеновский снимок мочевого пузыря, заполненного контрастом.

Мочевой пузырь

Мышечный резервуар, который хранит мочу до мочеиспускания.

Контрастное вещество

Жидкость, выглядящая белой на рентгене и позволяющая увидеть пузырь.

Катетер

Тонкая мягкая трубка для заполнения пузыря контрастом.

Надлобковый катетер

Катетер, дренирующий пузырь через переднюю брюшную стенку; контраст можно вводить через него.

Свищ (фистула)

Патологический ход между пузырём и другим органом, который можно выявить при цистограмме.

Рефлюкс

Заброс мочи из пузыря обратно к почкам.

Снимки при мочеиспускании

Дополнительные рентгеновские снимки, сделанные во время мочеиспускания, если это необходимо.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Большинство пациентов ощущают лишь наполненность или лёгкое давление при заполнении пузыря, но не острую боль. При установке катетера возможно кратковременное жжение. Персонал может замедлить или остановить процедуру в любой момент — просто скажите об этом. Исследование обычно занимает около 15–30 минут.

Как подготовиться (До исследования)

Подготовка минимальна. Как правило:

- Можно **есть и пить как обычно** и принимать **привычные лекарства**, если не указано иное.
- Если стоит катетер или надлобковый катетер, **оставьте его на месте** — контраст часто вводят через него.
- Обычно можно **ехать домой самостоятельно**, так как седация не требуется.

Заранее сообщите врачу, если вы:

- Переносили реакцию на контрастное вещество или йод
- Принимаете антикоагулянты
- Имеете признаки инфекции мочевыводящих путей (жжение, температура, мутная или резко пахнущая моча) — при активной инфекции исследование может быть перенесено

Что происходит во время исследования

- 1 Вы ложитесь на рентгеновский стол. Если катетера нет, аккуратно устанавливают небольшой катетер; если есть — подключают к нему.
- 2 Контраст медленно вводят в пузырь, одновременно делая рентгеновские снимки. Нужно лежать неподвижно и дышать спокойно.
- 3 При необходимости вас попросят **помочиться**, чтобы сделать снимки при опорожнении пузыря.
- 4 Снимки просматривают, катетер извлекают — или оставляют на месте, если он был установлен ранее.

После исследования

- Как правило, вы сразу можете идти домой и **вернуться к привычной жизни**.
- В течение дня возможно **лёгкое жжение при мочеиспускании**. Обильное питьё воды помогает и ускоряет его исчезновение.
- В моче может появиться **лёгкий розовый оттенок**. Это нормально и обычно проходит в течение суток.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб
- Затруднённое мочеиспускание или полная задержка мочи
- Сильное кровотечение или сгустки крови в моче
- Боль или спазмы в животе, которые усиливаются

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Цистограмма — быстрое и безопасное рентгенологическое исследование: пузырь заполняют контрастом, чтобы проверить заживление, выявить утечку, свищ или рефлюкс.
2. Подготовка минимальна. Оставьте катетер или надлобковый катетер на месте; заранее сообщите врачу об аллергии на контраст, приёме антикоагулянтов или признаках инфекции.
3. Большинство пациентов ощущают лишь наполненность и сразу едут домой. Лёгкое жжение или розовая моча в течение суток — норма; пейте больше воды и звоните врачу при температуре, сильном кровотечении или задержке мочи.